

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức — Nữ

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Rò nước tiểu khi ho, cười, nâng vật nặng hoặc vận động

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức (SUI) là tình trạng rò nước tiểu khi có áp lực đột ngột tác động lên bàng quang — khi ho, hắt hơi, cười, nâng vật nặng, hoặc vận động. Ở phụ nữ, tình trạng này xảy ra khi phần nâng đỡ dưới niệu đạo bị suy yếu, thường sau sinh hoặc mãn kinh. Đây là bệnh rất phổ biến và có thể điều trị tốt, từ bài tập đơn giản đến phẫu thuật nhanh và hiệu quả cao.

Về tình trạng này

Niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra ngoài) thường đóng kín khi bạn ho hoặc căng thẳng, nhờ cơ sàn chậu và các mô xung quanh nâng đỡ. Khi phần nâng đỡ này suy yếu, áp lực bụng tăng đột ngột sẽ đẩy nước tiểu ra ngoài. Đặc điểm nhận biết là **rò nước tiểu khi hoạt động** — không phải do tiểu gấp (đó là bàng quang tăng hoạt; có cả hai gọi là tiểu không kiểm soát **hỗn hợp**).

Nguyên nhân

- **Thai kỳ và sinh con** (nguyên nhân hàng đầu)
- **Mãn kinh** và lão hóa
- Ho mãn tính, táo bón, hoặc thường xuyên nâng vật nặng
- Thừa cân và tiền sử phẫu thuật vùng chậu

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Rò nước tiểu khi có áp lực — ho, nâng vật nặng, vận động.

Niệu đạo

Ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể.

Sàn chậu

Các cơ nâng đỡ bàng quang và niệu đạo.

Bài tập Kegel

Bài tập cơ sàn chậu giúp tăng cường nâng đỡ.

Tiểu không kiểm soát hỗn hợp

Có cả rò do gắng sức lẫn rò do tiểu gấp.

Vòng nâng / nút hỗ trợ

Dụng cụ nhỏ đặt trong âm đạo để giảm rò nước tiểu.

Tiêm chất làm đầy niệu đạo

Tiêm vào phòng khám giúp niệu đạo đóng kín hơn.

Băng nâng giữa niệu đạo

Băng lưới nhỏ đặt dưới niệu đạo trong phẫu thuật.

TÔI CÓ CẦN PHẪU THUẬT KHÔNG? Không nhất thiết. Nhiều phụ nữ cải thiện nhờ bài tập cơ sàn chậu và thay đổi lối sống, một số dùng dụng cụ hỗ trợ. Phẫu thuật (như băng nâng) rất hiệu quả nếu bạn muốn kết quả lâu dài — nhưng đây là lựa chọn của bạn, và bạn có thể bắt đầu từ các bước đơn giản hơn.

Chẩn đoán như thế nào

- Hỏi về thời điểm rò nước tiểu và khám lâm sàng (đôi khi có thử nghiệm ho)
- **Xét nghiệm nước tiểu** để loại trừ nhiễm trùng, kiểm tra khả năng tổng tiểu
- Đôi khi cần đo niệu động học (urodynamics) trước phẫu thuật

Điều trị như thế nào (từng bước)

- 1 **Bài tập cơ sàn chậu** (Kegel) và vật lý trị liệu, giảm cân, điều trị ho và táo bón.
- 2 **Dụng cụ hỗ trợ** — vòng nâng âm đạo hoặc nút hỗ trợ không kê đơn.
- 3 **Tiêm chất làm đầy niệu đạo** — tiêm nhanh tại phòng khám giúp niệu đạo đóng kín hơn.
- 4 **Phẫu thuật** — **băng nâng giữa niệu đạo** (hoặc băng nâng từ mô tự thân) để điều trị lâu dài. Mỗi lựa chọn có tờ thông tin riêng.

Sống chung với tình trạng này

- Tập thói quen **siết cơ sàn chậu trước khi ho, hắt hơi, hoặc nâng vật nặng** (gọi là "kỹ thuật phòng ngừa").
- Tập bài tập cơ sàn chậu mỗi ngày — có thể mất 6–12 tuần mới thấy hiệu quả.
- Điều trị táo bón và ho mãn tính để giảm áp lực bụng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Cảm giác nóng rát, tiểu gấp, hoặc **tiểu ra máu** (có thể là nhiễm trùng)
- Rò nước tiểu kèm theo **tiểu gấp mạnh** — cần điều trị khác
- Cảm giác bàng quang không tổng tiểu hết

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Tiểu không kiểm soát khi gắng sức ở phụ nữ là rò nước tiểu do áp lực vì phần nâng đỡ niệu đạo bị suy yếu — rất phổ biến và có thể điều trị tốt.
2. Các lựa chọn gồm bài tập cơ sàn chậu, dụng cụ hỗ trợ, tiêm chất làm đầy tại phòng khám, đến băng nâng cho kết quả lâu dài.
3. Bài tập cần nhiều tuần mới có hiệu quả; hãy siết cơ trước khi ho hoặc nâng đồ. Phẫu thuật là lựa chọn, không bắt buộc.